

Trastornos del Neurodesarrollo

Retraso global del desarrollo y Discapacidad intelectual

Pediatría Integral Módulo: Septiembre 2020

En un niño en el que se detecta un trastorno o retraso del desarrollo puede significar:

1. Variante normal del desarrollo que implica una normalización posterior.
2. Inadecuada estimulación.
3. Retraso derivado de una enfermedad crónica extraneurológica, como puede ser: desnutrición, cardiopatías congénitas, enfermedad celiaca o déficits neurosensoriales, entre otros.
4. Retraso global del desarrollo.
5. Primera manifestación de un:
 - Trastorno motor crónico no progresivo (parálisis cerebral)
 - Discapacidad intelectual futura
 - Trastorno del espectro autista (TEA)
 - Trastorno del lenguaje
 - Trastorno de la coordinación motora
 - Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

Por tanto, en un paciente con retraso en el desarrollo debemos iniciar una búsqueda etiológica y una estimulación específica, sin retrasar su abordaje.

Discapacidad intelectual

Trastorno que se inicia antes de los 18 años, caracterizado por:

- Limitación en el funcionamiento intelectual (que debe ser confirmado mediante CI)
+
- Afectación del comportamiento adaptativo
 - Conceptual: lenguaje, conocimiento y memoria
 - Social: empatía, juicio social y seguir reglas
 - Práctico: autocuidado, organización y actividades de vida diaria

Grados:

CI 70-85: funcionamiento intelectual límite

CI 50-70: DI leve

CI 35-50: DI moderada

CI 20-35: DI grave

CI <20: DI profunda

En menores de 5 años, las pruebas de inteligencia son poco fiables, tanto por el elevado porcentaje de falsos positivos como negativos; por lo que, por debajo de esta edad, se habla de:

Retraso global del desarrollo (RGD)

El RGD implica un retraso en, al menos, dos áreas de desarrollo:

- Motricidad fina-gruesa
- Lenguaje
- Sociabilidad
- Cognición
- Actividades de la vida diaria

Etiología del RGD/DI

23-78%: sin causa definida (variable según el área geográfica)

En general el DI grave, se suele encontrar una causa en hasta el 80% de las ocasiones.

El diagnóstico de RGD debe ser precoz. Debemos transmitir a los padres que la detección de un trastorno del neurodesarrollo no es “etiquetar” al niño, sino una identificación de necesidad de estimulación.

La escala de desarrollo más utilizada y validada en Europa es la de **Haizea-Llevant**.

Comprende 97 ítems distribuidos en áreas de: socialización, lenguaje, manipulación y postural, en los que podremos identificar si el niño ha adquirido ese ítem del desarrollo de forma adecuada a su edad.

En nuestro medio utilizamos la **Prueba Nacional de Pesquisa** (PRUNAPE) (ver en el título “Crecimiento y desarrollo” de esta bibliográfica).

Causas prenatales (50-60%)

1. Trastornos genéticos (60-65%)

- Alteraciones cromosómicas estructurales
- Mutaciones puntuales monogénicas
- Deleciones-duplicaciones
- Herencia poligénica

2. Errores innatos del metabolismo (1-5%)

3. Trastornos malformativos no definidos por un defecto genético establecido (20-25%)

- Malformaciones congénitas del SNC
 - Defectos del tubo neural
 - Defectos de línea media cerebral
 - Defectos proliferación celular
 - Defectos migración celular
 - Defectos organización celular
- Síndromes con malformaciones múltiples

4. Por efecto de noxas externas (30-35%)

- Infecciosas
 - TORCH**, sífilis congénita, VIH, ZIKA, otras
- Tóxicos
 - Alcohol, drogas, tóxicos industriales, fármacos (ácido valproico, talidomida...), radiación ionizante.
- Causas vasculares
 - Isquemia prenatal y trombofilia prenatal
- Causas placentarias:
 - CIR, prematuridad, enfermedad crónica materna

Causas perinatales (4-15%)

- Relacionados con el parto
 - Sufrimiento fetal agudo y/o trauma obstétrico
- Factores tóxicos
 - Hiperbilirrubinemia
 - Plomo, mercurio, etc.
- Otras causas
 - Infecciones SNC, sepsis neonatal, hipoglucemia persistente

Causas postnatales (3-10%)

- Infecciosas: meningitis o encefalitis de diferentes etiologías
- Autoinmunes/Parainfecciosas
- Traumáticas
 - “Síndrome del bebé zarandeado”, politraumatismo, daño axonal difuso.

- Tumorales
- Vasculares
- Epilepsia (encefalopatías epilépticas)
- Factores tóxicos
- Enfermedades sistémicas
 - Endocrinológicas (hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, panhipopituitarismo)
 - Inmunodeficiencias
- Nutricionales
 - Malnutrición, déficit vitamínicos específicos como: vitamina B1 o vitamina B12
- Psicosociales
 - Niños maltratados, abandonados, hospicios, adopciones internacionales, falta de estimulación